

NS

LUIS GUSTAVO SOARES

IDADE: 40 anos PESO: 115 ALTURA: 1,75 PROFISSÃO: Empresário
 SINTOMAS: Dor no peito, cansaço, sonolência diurna, tontura.
 QUEIXAS: nariz; nariz.
 MEDICAMENTOS: 0

MÉDICO: Dr Roberto Borroni

EXERCÍCIO FÍSICO: -

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 23h30' HORA QUE ACORDA: 6h30'

COCHILHO (X)SIM ()NÃO DORME ACOMPANHADO (X)SIM ()NÃO ()EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X)SIM ()X NA SEMANA ()NÃO FDS.

FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nariz BANHEIRO: 6x.

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI: IV

IAH: 89,5 e/h SPO2: 69%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N)NASAL (N)AMIGDALECTOMIA S/ desvio

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Asma na infância

COMORBIDADE: (S)RESPIRATÓRIA (N)ENDÓCRINA (N)CARDÍACA

()ORTOPÉDICA (N)NEUROLÓGICA ()OUTROS

PSG cl titulação - CPAP: 7,0 cmH₂O → IAH=55,0 SpO2 80%.

22/12/2023 Adaptação Auto 4 a 12 cmH₂O / nariz
 04/01/2024 P= 9,7 cmH₂O Press 95% = 11,3 cmH₂O. (M)
 IAH=3,9 e/h

m. de uso = 6h08'

fluxo = 43 l/min.

* P: 6 à 11 cmH₂O.

↑ umidade 5

17/01 P= 10 cmH₂O

24 IAH=0,8 e/h

m. de uso: 7h

fluxo = 11,4 l/min

fluxo

03/05/24

P= 10 cmH₂O

IAH= 3,9 e/h

m. de uso: 6h43m

fluxo: 6,9 l/min

Bem adaptado

Natacha

06/08 P=10auHeO
24 IAH=2,4 e/h
m de uso: 6h6'
fuge: 4,9 e/m

Bem adaptado
Natasha

Nome: LUIS GUSTAVO SOARES
Data de Nascimento: 12-11-1983
IMC: 32,72
Sexo: Masculino
Data do exame: 04-09-2023

Peso: 112 kg
Altura: 1,85 m
Médico: DR. ROBERTO BONANONI
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 04-09-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 546,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 11,0 e 145,5 minutos. O tempo total de sono foi de 437,0 min, eficiência de 80,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,1%; estágio N2: 69,8%; estágio N3: 6,1%; sono REM: 21,1%. O índice de despertares foi de 53,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 89,5/hora, sendo 132 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 193 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e a mínima de 69%, permanecendo 28,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 63 - 120 bpm e NREM de 66 - 121 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (19), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 89,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=69%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: LUIS GUSTAVO SOARES

Data de Nascimento: 12-11-1983

IMC: 32,14

Sexo: Masculino

Data do exame: 21-11-2023

Peso: 110 kg

Altura: 1,85 m

Médico: DR. ROBERTO BONANOMI

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 21-11-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 484,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 52,5 e 320,5 minutos. O tempo total de sono foi de 210,5 min, eficiência de 43,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 6,2%; estágio N2: 62,5%; estágio N3: 16,9%; sono REM: 14,5%. O índice de despertares foi de 20,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 55,0/hora, sendo 90 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 103 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 80%, permanecendo 6,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 67 - 104 bpm e NREM de 62 - 111 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (15), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. registro de ronco durante o sono.

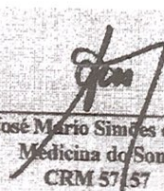
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 7,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157